

Depresja *narcystyczna*

Pojawia się po narcissistic injury — krytyce, porażce, utracie supply. Rdzeń to **wstyd i pustka**, nie smutek. Wysokie ryzyko samobójcze — i klinicznie niedoceniane.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Kohut (1977); Ronningstam & Maltsberger (1998)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, czym depresja narcystyczna *różni się* od klasycznej depresji (sekcja 01). **2** · Poznasz cztery typowe wyzwalacze *narcissistic injury* (sekcja 02). **3** · Zobaczysz, dlaczego klasyczne leczenie samymi lekami przeciwdepresyjnymi *nie wystarcza* (sekcja 03). **4** · Sprawdzisz, jak rozpoznać wysokie ryzyko samobójcze, które jest *niedoceniane* u osób z NPD (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Depresja narcystyczna (Kohut 1977) różni się fenomenologicznie od klasycznej depresji — rdzeniem *nie* jest smutek czy beznadziejność, ale **wstyd, pustka i poczucie utraty self**. Występuje typowo po *narcissistic injury*: krytyce, publicznej porażce, utracie pracy, rozstaniu, starzeniu się. Ronningstam & Maltsberger (1998) opisali ten obraz jako połączenie grandiozyjności („powinienem być najlepszy/-a”) z **rozpaczą** („nie jestem”). Mechanizm: *narcissistic injury* aktywuje ukryty schemat defektywności. Bez supply grandiozyjny self **kolapsuje**, odsłaniając pustkę. Pacjent doświadcza *nie* klasycznego smutku, tylko **dezintegracji self**: „nie wiem, kim jestem”, „wszystko jest puste”. *Ryzyko samobójcze*: Ronningstam (2008) wykazała, że pacjenci z NPD mają **wyższe** ryzyko samobójcze niż populacja ogólna — ale jest ono *niedoceniane*, bo „narcyz wygląda dobrze”. Typowy wzorzec: zewnętrznie sprawne życie + nagły kryzys (rozwód, zwolnienie) + szybki zwrot ku ekstremalnemu rozwiązaniu. *Konsekwencja kliniczna*: klinicysta widzi epizod depresyjny i przepisuje selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny (SSRI) + standardową terapię poznawczo-behawioralną. Objawy częściowo ustępują, ale rdzeń wstydu pozostaje. Po kolejnym *narcissistic injury* — nawrót, często gorszy. Pacjent uznaje, że „leki nie działają”. Skuteczne podejście to **integracja**: farmakoterapia (SSRI redukuje wstyd, lit/lamotrygina stabilizuje labilność) + długa psychoterapia adresująca podłoże NPD.

01 Cztery różnice — depresja narcystyczna vs klasyczna

1 · WYZWALACZ

Klasyczna: stresory ogólne, biologia, sezonowość.
Narcystyczna: *narcissistic injury* — utrata supply, krytyka, porażka.

2 · RDZEŃ DOŚWIADCZENIA

Klasyczna: smutek, beznadziejność, wina, anhedonia.
Narcystyczna: *pustka, bezwartościowość, wstyd, utrata self*.

3 · KIERUNEK ZŁOŚCI

Klasyczna: autoagresja, „to moja wina”.
Narcystyczna: *furia na świat*, „oni mnie nie docenili”.

4 · DYNAMIKA

Klasyczna: tygodnie/miesiące, powolny przebieg.
Narcystyczna: *szybka remisja*, gdy supply wraca; nagłe nawroty.

Pytanie różnicujące: *nie* „czujesz się smutny/-a?” — tylko: „**czy czujesz się mniej sobą?**” Pacjent z depresją narcystyczną często odpowie „tak — to jak zniknięcie wszystkiego, co budowałem/-am”, co jest *innym* obrazem niż klasyczny smutek.

02 ☉ Cztery typowe wyzwalacze — *narcissistic injury*

1 · UTRATA PRACY / STATUSU

Zwolnienie, awans, który ominął, przejście na emeryturę. Status = supply. Bez statusu — kolaps grandiozyjnego self.

2 · ROZWÓD / ROZSTANIE

Szczególnie *jeśli to partner odszedł*. Sygnał, że nie byłem/-am wystarczający/-a. Niemożność znalezienia szybkiego zastępstwa pogłębia kryzys.

3 · STARZENIE SIĘ

Utrata atrakcyjności, zdrowia, sprawności. Sigma 50–60 r.ż. — najsilniejsze ryzyko depresji narcystycznej u mężczyzn z grandiozyjnym NPD.

4 · PUBLICZNE UPOKORZENIE

Skandal w pracy, ujawnienie błędu, zhańbienie w mediach. Świadkowie zewnętrzni utrwalają wstyd — z którego trudno się wycofać.

03 🧠 Dlaczego same SSRI nie wystarczą

CO DZIAŁA OBJAWOWO

SSRI: redukcja wstydu, lęku, anhedonii.
Lit/lamotrygina: stabilizacja labilności.
Antydepresanty pomagają — ale nie zmieniają struktury NPD.

CO POTRZEBNE DODATKOWO

Terapia adresująca *narcissistic vulnerability*: terapia schematów (Bamelis 2014), CFT (Gilbert), MBT (Fonagy). Bez tego — nawrót przy każdej kolejnej *injury*.

04 ✎ Ryzyko samobójcze — niedoceniane u NPD

Ronningstam (2008): wskaźnik samobójstw u osób z NPD jest **wyższy** niż w populacji ogólnej. Klinicznie *niedoceniany*, bo pacjent „wygląda dobrze” — utrzymuje fasadę aż do końca. Sygnały ostrzegawcze:

- ☐ Nagła utrata **głównego źródła supply** (praca, partner, status) w ostatnich 6 miesiącach
- ☐ Wycofanie z dawnych aktywności — bez mówienia o smutku, raczej „przemyślenia”
- ☐ Porządkowanie spraw (rachunki, testament, pożegnalne rozmowy) — przedstawiane jako „racjonalne”
- ☐ Bardzo niska tolerancja zwyczajności — „albo wszystko, albo nic”
- ☐ Słowa typu: „świat byłby lepszy beze mnie”, „nie ma sensu”, „nikt nie zauważy”
- ☐ Wysokie kompetencje wraz z dostępem do środków

Dwa lub więcej znaków = pilna konsultacja psychiatryczna. W Polsce: Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 (bezpłatny, 14:00–22:00), Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego 800 70 22 22 (bezpłatny, całodobowy). W stanie ostrym: izba przyjęć szpitala psychiatrycznego albo numer 112.

Klucz: depresja narcystyczna to *nie* „manipulacja” — to realny ból pod grandiozją. Klinicznie niedoceniana, bo pacjent utrzymuje fasadę. **Paradoks terapeutyczny:** narcyz z depresją jest *bardziej* dostępny terapeutycznie niż w fazie pełnej grandiozji — bo cierpi, motywacja jest realna. To *okno terapeutyczne*. Nie marnuj go zbyt agresywnym podejściem — pacjent jest kruchy. Walidacja bólu pod fasadą, stabilizacja farmakologiczna, dopiero potem długa praca z podłożem NPD (Ronningstam & Maltsberger 1998).